Faringitis crónicas

L. Vazel, C. Martins, G. Potard, R. Marianowski

La faringe es la zona de confluencia aerodigestiva que interviene en la respiración, la fonación, la gustación y la olfacción. En este órgano accesible a la exploración física suelen localizarse diversos trastornos funcionales. La etiología de las enfermedades faríngeas es múltiple y existen causas de origen local o general, ascendentes (gástricas) o descendentes (nasosinusales). Se debe sospechar la naturaleza neoplásica de cualquier lesión que se observe en la mucosa faríngea del paciente fumador. La exploración física debe ser minuciosa. La práctica de estudios específicos permite establecer el tratamiento adecuado.

© 2005 *Elsevier SAS. Todos los derechos reservados.*

Palabras Clave: Faringitis crónica; Cáncer; Faringitis bacterianas; Faringitis víricas; Faringitis micóticas; Faringitis granulosas

Plan

- **Introducción** 1
- **Anatomía** 1
- **Fisiología e inmunología** 2
  - Reseña fisiológica 2
  - Reseña inmunológica 3
- **Exploración física** 3
  - Anamnesis 3
  - Exploración física 3
  - Formas anatomoclínicas 3
- **Pruebas complementarias** 3
  - Pruebas de laboratorio 3
  - Pruebas de diagnóstico por imagen 4
  - Endoscopia bajo anestesia general 4
- **Etiología** 4
  - Portador crónico de estreptococo β-hemolítico del grupo A (EBA) 4
  - Causas tóxicas 4
  - Causas descendentes 4
  - Causas ascendentes 4
  - Causas locales 4
  - Causas generales 4
  - Origen iatrogénico 5
- **Diagnóstico diferencial** 5
  - Con lesión mucosa 5
  - Sin lesión mucosa clínica 6
- **Tratamiento** 6
  - Normas higienicodietéticas 6
  - Tratamiento local 6
  - Tratamiento regional 7
  - Tratamiento general 7
  - Crenoterapia 7

Introducción

Verdadera zona de confluencia anatómica entre las vías aéreas y las vías digestivas superiores, la faringe interviene en varias funciones vitales (respiración, deglución) y sociales (fonación, gustación y olfacción).

Con frecuencia, el médico se enfrenta en la consulta a síntomas referidos a la faringe, pero cuya causa no es sólo local. En Estados Unidos, por ejemplo, provocan cerca de 40 millones de consultas al año.

A causa de su etiología múltiple, no existe ninguna definición precisa de faringitis crónica. Puede deberse a la alteración de una o de las tres partes de la faringe, aparecer de forma más o menos progresiva y tener una evolución más o menos subaguda o larvada, cuyo tratamiento será el factor desencadenante. Con frecuencia es expresión de una enfermedad en la proximidad o de una causa medioambiental.

En el estudio de cualquier faringitis crónica, hay que descartar siempre la etiología neoplásica [2].

Anatomía

Según su acción digestiva o respiratoria, la faringe pone en relación, bien la boca con el esófago, o bien la nariz y la cavidad oral con las vías respiratorias inferiores. Estas dos corrientes presentan un control nervioso central diferente.

La faringe es un órgano musculomembranoso constituido de arriba abajo por tres segmentos (Figs. 1 y 2).

La rinofaringe se extiende desde la base del cráneo hasta el borde libre del velo del paladar, que, cuando se contrae, aísla por completo la rino y la hipofaringe. Se abre por delante en las coanas, y se corresponde por detrás con el arco anterior del atlas y, lateralmente, con los dos orificios tubáricos.

La orofaringe se extiende desde el borde libre del velo del paladar hasta el repliegue glosoepiglótico; a partir de

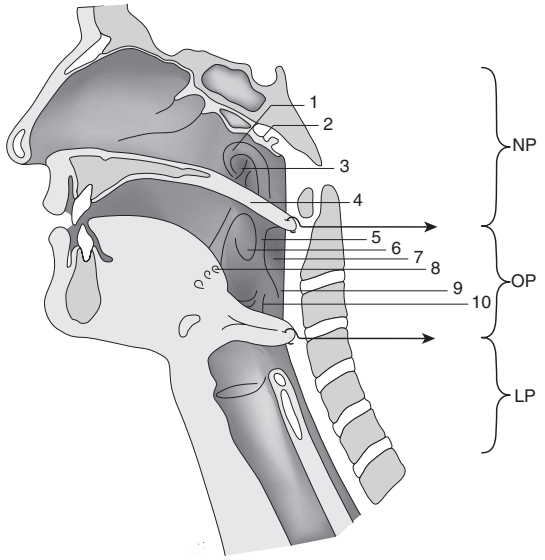

Figura 1. Faringe: corte sagital (según Sobotta, Atlas d'anatomie humaine, tome 1.Cachan, 1994: 132-156).
1. Rodete tubárico; 2. amígdala faríngea; 3. ostium faríngeo de la trompa auditiva; 4. paladar blando; 5. arco palatofaríngeo; 6. amígdala palatina; 7. pliegue salpingofaríngeo; 8. agujero ciego; 9. fascia faringobasilar; 10. pliegue faringoepiglótico; NF: nasofaringe; OF: orofaringe; LF: laringofaringe.

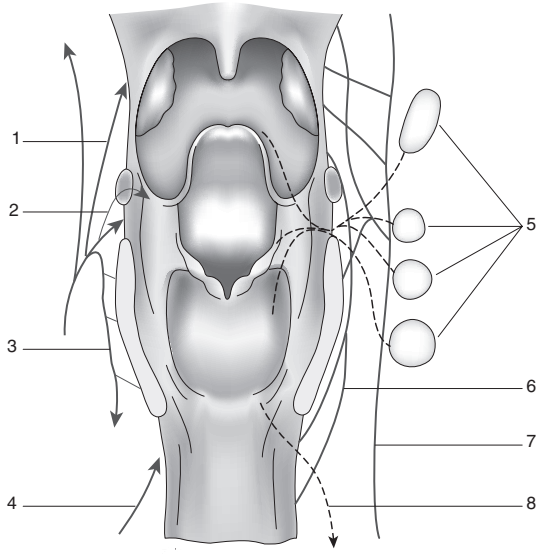

Figura 2. Vascularización; vista posterior de la faringe (según Dehesdin y Choussy, Anatomie du pharynx, EMC, Oto-rhino-laryngologie, 20-491-A-10).
1. Arteria faríngea ascendente; 2. arteria palatina descendente; 3. arteria tiroidea superior; 4. arteria tiroidea inferior; 5. grupo lateral de los ganglios linfáticos yuguloomohioideos; 6. arcada venosa laterofaríngea; 7. vena yugular interna; 8. colector del plano infraglótico.

aquí, la hipofaringe continúa hasta el esófago, correspondiéndose con las cuatro últimas vértebras cervicales.

La vascularización arterial de la faringe proviene en su mayor parte de la arteria faríngea ascendente, que nace de la carótida externa por encima de la arteria lingual y se aplica inmediatamente sobre la pared faríngea en la que se distribuye. De manera accesoria, la faringe se encuentra vascularizada por la arteria pterigopalatina (para la bóveda faríngea), la arteria palatina inferior y la arteria tiroidea superior.

Las venas que provienen de la mucosa forman un primer plexo submucoso. De este plexo nacen las ramas que atraviesan la musculatura y constituyen en la cara externa de la faringe un segundo plexo superficial, cuyas ramas eferentes o venas faríngeas desembocan en la vena yugular interna.

Los linfáticos forman dos redes, una intramuscular, poco desarrollada, y otra mucosa que comunica con los órganos vecinos. Los troncos eferentes se reparten en tres grupos: posterior, que se dirige al espacio retrofaríngeo y después a los ganglios más elevados de la cadena yugular; lateral, que se reúne con los linfáticos amigdalinos para dirigirse a los ganglios cervicales profundos situados a lo largo del borde inferior del digástrico; y el grupo anteroinferior, que sigue los senos piriformes para unirse a los linfáticos laríngeos y se dirige hacia los ganglios medios de la cadena yugular interna.

■ Fisiología e inmunología

Reseña fisiológica [4, 6, 9]

La faringe desempeña un papel activo en la deglución. A cada deglución la precede y sigue una inhibición respiratoria, y se desarrolla según un proceso constante en forma de onda peristáltica en la que participan los músculos faríngeos, el velo, los músculos supra e infrahioideos y laríngeos. La inervación motora, cuyo centro lo representa ante todo el núcleo ambiguo, corresponde al vagoespinal. Los nervios glosofaríngeo y vago aseguran la sensibilidad de las paredes faríngeas y del tercio posterior de la lengua.

Aparte de la alimentación, la deglución suele desencadenarse por las secreciones nasales, traqueobronquiales y la saliva. Durante la alimentación, la deglución es un acto voluntario que se adapta al tipo de alimento. Cuando el bolo alimenticio franquea el istmo de la faringe, los movimientos de la lengua, del velo y de la pared faríngea posterior lo proyectan en la orofaringe.

El velo es atraído hacia arriba y hacia atrás, llega a contactar con la pared faríngea posterior y bloquea la rinofaringe. El hueso hioides realiza un desplazamiento anterosuperior al que sigue la laringe, cuyas cuerdas vocales quedan en aducción. La contracción de los músculos aritenoepiglóticos asegura la basculación de la epiglotis sobre el vestíbulo. La ascensión de la laringe también produce el ensanchamiento de la hipofaringe en sentido transversal. La deglución finaliza con la contracción activa del músculo cricofaríngeo. Una inspiración siempre sigue a esta fase faríngea de la deglución.

La onda peristáltica afecta a todos los músculos faríngeos y progresa a la velocidad de 12-25 cm por segundo. El bolo así deglutido atraviesa el esfínter a 70 cm/s. Esta velocidad depende del tamaño del bolo alimenticio.

El acto faríngeo de la deglución también contribuye a la digestión, ya que las glándulas de Ebner secretan una lipasa. Estas glándulas están situadas en el velo y en la base de la lengua, pero el mecanismo exacto de estimulación sigue siendo desconocido.

La faringe interviene en la fonación y, sobre todo, en la formación de las vocales: es el refuerzo de determinados armónicos por el paso del sonido a través de la cavidad faríngea y bucal lo que otorga a la vocal su carácter propio. La faringe confiere el formante grave, y la cavidad bucal el formante agudo. Según la naturaleza de su formante y la mayor o menor apertura del conducto faringobucal, las vocales pueden clasificarse en vocales anteriores o posteriores y en vocales cerradas o abiertas. Los efectores bucales condicionan de manera esencial la formación de las consonantes.

La rinofaringe desempeña un papel en la olfacción y, especialmente, en la corriente espiratoria. Así, durante la deglución, percibimos los olores de origen alimentario

por difusión retronasal. De esta forma, se produce la doble estimulación gustativa y olfativa que permite reconocer los alimentos.

Las papilas gustativas se encuentran a nivel del velo, en la cara laríngea de la epiglotis y en las caras posteriores de la faringe; los estímulos sensoriales se transmiten a través de las ramas de los nervios trigémino y glosofaríngeo.

Durante la respiración, la faringe presenta movimientos que no son de naturaleza peristáltica, sino de tipo agonista-antagonista, como ocurre en el árbol respiratorio. La faringe recibe el aire inspirado por la nariz, calentado y humidificado. Cuando existen problemas de ventilación nasal, el aire puede ser inspirado de forma anormal por la boca. En este caso, la faringe asume las funciones que corresponden a las fosas nasales, pero lo hace de forma imperfecta, consiguiendo calentar y humidificar menos el aire.

Reseña inmunológica [8, 9]

La faringe constituye un espacio de transición entre la cavidad oral y su mucosa (epitelio mucoso estratificado no queratinizado), y los epitelios respiratorios y digestivos. Se encuentra recubierta de epitelio escamoso estratificado, salvo en las regiones no sometidas a la abrasión, donde es cilíndrica seudoestratificada con células caliciformes.

Los epitelios están bañados por la saliva, líquido de composición compleja, especialmente rico en inmunoglobulinas (Ig) A secretoras, cuyo principal papel es el de prevenir la adherencia de los microorganismos a las superficies mucosas y neutralizar los virus [8].

El sistema inmunitario anexo a las mucosas de las vías aerodigestivas superiores (VADS) se compone de un tejido linfoide difuso que forma parte del anillo de Waldeyer: lo constituyen las vegetaciones y las amígdalas palatinas y linguales. Su epitelio es críptico y hace de interfaz entre los antígenos en tránsito y las células inmunitarias que son las células M. En el tejido amigdalino se pueden identificar todos los tipos celulares implicados en los mecanismos inmunitarios (macrófagos, células foliculares dendríticas, células interdigitantes, plasmocitos que fabrican IgG, A, M, D y linfocitos T y B). No obstante, es preciso destacar el predominio de la población de plasmocitos secretores de IgG en relación con los que segregan IgA.

Las vegetaciones y las amígdalas tienen una disposición estratégica para captar los numerosos antígenos que aportan la alimentación y la respiración; la defensa específica se efectúa por intermediación de anticuerpos específicos o de linfocitos.

El tejido linfoide asociado a las mucosas se desarrolla fundamentalmente después del nacimiento, y parece que para su proliferación es necesaria la presencia de antígenos exógenos. En el lactante, el contacto repetido con numerosos antígenos selecciona una célula específica para cada antígeno y genera una respuesta inmunitaria que produce un clon de células idénticas. Por tanto, la mucosa otorrinolaringológica (ORL) tiene la doble función de información antigénica y de protección contra los agentes patógenos inhalados e ingeridos.

■ Exploración física

Anamnesis

En general, el paciente acude a la consulta porque presenta síntomas presididos por molestias faríngeas mal sistematizadas, a menudo difíciles de caracterizar. Suelen localizarse en la orofaringe o la hipofaringe; pueden referirse a la zona lateral o media y aumentan con la deglución. Con frecuencia se describen como sensación de quemadura, picor, cuerpo extraño y, a veces, de bola en la garganta o espina irritativa [3, 7].

En ocasiones, el paciente puede localizar con más precisión los síntomas a nivel de las amígdalas o de la base de la lengua. Esta región se proyecta en el cuello por dentro del ángulo mandibular. En caso de alteración hipofaríngea, se proyecta en la región tiroidea.

Las molestias que el paciente refiere son más o menos antiguas y suelen encontrarse antecedentes repetidos de automedicación. El paciente también puede describir sensación matinal de faringe rasposa, tenesmo faríngeo, tos nocturna y regurgitaciones a distancia de las comidas.

El interrogatorio más general investigará, además de la edad y el sexo del paciente (sobre todo varones de 30-50 años), la existencia de antecedentes de consumo de alcohol y tabaco, tabaquismo pasivo, exposición a irritantes como el polvo, antecedentes de diabetes, inmunosupresión general y otras enfermedades metabólicas. También se deben constar los antecedentes ORL médicos y quirúrgicos.

Exploración física

Hay que practicar una exploración ORL completa y sistemática de la mucosa de los tres pisos de la faringe y del cavum mediante nasofibroendoscopia para descartar la existencia de neoplasia subyacente, asociando a la palpación de la base de la lengua y de las fosas amigdalinas la de la cavidad oral. Se exploran también las áreas ganglionares cervicales y la glándula tiroides.

Se investigará la existencia de rinorrea posterior, inflamación de la mucosa nasal y derrame purulento en los meatos medios; También se examinará la dentición, controlando la higiene de las eventuales prótesis dentales.

El estudio debe incluir también la búsqueda con el nasofibroendoscopio de signos indirectos de reflujo gastroesofágico, como eritema de la cara posterior de los aritenoides o edema del brocal posterior de la laringe.

Formas anatomoclínicas

La exploración de la faringe permite establecer una clasificación exhaustiva de los aspectos anatomoclínicos de las faringitis crónicas [3, 7]:

- la faringitis congestiva en la que el enantema es difuso y recubre la totalidad del velo del paladar y de la faringe; la mucosa aparece engrosada y recubierta por una capa opalescente que se organiza durante los movimientos de la faringe en regueros blanquecinos en los pliegues;
- la faringitis purulenta o mucopurulenta que en el adulto es manifestación de una afección nasal o nasosinusal;
- la faringitis atrófica con mucosa lisa, seca, sin islotes linfoides identificables, que suele acompañar a la ocena;
- la faringitis hipertrófica y granulosa que indica la presencia de pequeños folículos lenticulares rosados o amarillentos, o de un punteado de minúsculas burbujas traslúcidas inmersas en el espesor de la mucosa.

■ Pruebas complementarias

Pruebas de laboratorio

El estudio analítico investigará la existencia de síndrome inflamatorio, diabetes, hiperglucemia en ayunas, hipertrigliceridemia y uremia.

Para descartar el origen bacteriano, y sobre todo micótico, se tomarán muestras faríngeas mediante raspado con hisopo.

Pruebas de diagnóstico por imagen

El estudio radiológico se realiza para confirmar o descubrir focos infecciosos en la proximidad. Según los datos recogidos durante la exploración física, pueden solicitarse ortopantomografías, radiografías en proyección de Blondeau, tomografía computarizada (TC) de senos paranasales y tránsito esofágico.

El reflujo gastroesofágico sospechado durante la anamnesis o la exploración física se puede confirmar mediante pH-metría o fibroendoscopia gástrica.

Endoscopia bajo anestesia general

En caso de consumo abusivo de alcohol y tabaco, ante cualquier lesión mucosa sospechosa, se practicará endoscopia de las VADS bajo anestesia general y biopsia de la misma, o bien de forma sistemática en busca de neoplasia.

■ Etiología

Ante el paciente que presenta un cuadro de faringitis crónica, la búsqueda de la etiología debe hacerse con rigor, ya que condiciona la esperanza de curación.

Portador crónico de estreptococo β-hemolítico del grupo A (EBA)

La eliminación del EBA de la orofaringe puede estar abocada al fracaso en el 25% de los pacientes tratados por antibioticoterapia. No todos son sintomáticos.

El fracaso del tratamiento puede deberse a complicaciones locales o a la insuficiencia del propio tratamiento. Suele achacarse al incumplimiento del tratamiento prescrito. En 1998, Steel sugirió como causa de dicho fracaso terapéutico la emergencia de cepas resistentes a la penicilina en Asia y en Europa. Se ha podido demostrar la resistencia relativa a la penicilina por parte del EBA cuando existe infección concomitante por organismos productores de β-lactamasas.

El estado de portador es frecuente; se puede encontrar en el 20% de los niños escolarizados. Lo caracteriza la colonización de la orofaringe por estreptococos piógenes sin signos clínicos de infección ni respuesta inmune. Los portadores suelen ser asintomáticos y no necesitan antibioticoterapias repetidas. Sigue siendo difícil diferenciar al portador de EBA que presenta una infección concomitante viral o bacteriana de otra etiología, del paciente que presenta faringitis por EBA sintomática. La anamnesis cuidadosa y el conocimiento de la epidemiología ayudarán al clínico a identificar qué pacientes deben recibir antibioticoterapia.

La existencia de varios casos familiares recidivantes sin confirmación bacteriológica hizo que Bisno et al, en 1997, propusieran que los animales domésticos, los perros y, con menor frecuencia, los gatos pudieran ser portadores de EBA.

Causas tóxicas

Presiden la etiología de las faringitis crónicas.

Se trata, ante todo, de excesos en el consumo de alcohol y de tabaco. La mucosa de la faringe suele aparecer muy inflamada, en especial a nivel de los pilares anteriores. También se puede apreciar un aspecto hipertrófico o inversamente atrófico de la mucosa. Las modificaciones epiteliales y de las células de defensa (macrófagos) se observan sobre todo en los casos de intoxicación tabáquica.

Se describen algunos factores agravantes de las faringitis crónicas: la contaminación atmosférica por los humos de los hidrocarburos, el polvo y el aire acondicionado demasiado seco o demasiado húmedo.

También existen etiologías tóxicas industriales porque muchos productos pueden desencadenar irritaciones faríngeas crónicas: el polvo de cemento, de cal, de algodón, de hierro, de cromo y la mayoría de los productos químicos y herbicidas.

Causas descendentes

Las enfermedades crónicas de las fosas nasales y de los senos paranasales pueden ser el origen de la faringitis.

Así, la obstrucción crónica de las fosas nasales (por desviación septal, hipertrofia de los cornetes inferiores o concha bullosa) favorece la respiración bucal, que da lugar a la desecación de la mucosa faríngea.

Las rinitis o rinosinusitis crónicas con rinorrea posterior purulenta o mucopurulenta provocan una inflamación que se extiende progresivamente. El aspecto clásico es la forma purulenta con eritema de los repliegues salpingofaríngeos.

A menudo se observan infecciones dentales, simples caries o parodontopatías. La halitosis es frecuente.

Causas ascendentes

En el caso del reflujo gastroesofágico, el diagnóstico es ante todo clínico. La anamnesis se dirigirá a los antecedentes de pirosis, regurgitaciones y gastralgias asociadas a tos seca nocturna. En la exploración nasofibroendoscópica se observan signos indirectos de reflujo, como eritema, e incluso ulceración, de la cara posterior de los aritenoides, la comisura posterior o los senos piriformes. La pH-metría o la desaparición de los síntomas con el tratamiento antirreflujo de prueba confirmarán el diagnóstico.

También pueden estar implicadas otras enfermedades digestivas como esofagitis, gastritis, hernias hiatales o úlceras gastroduodenales. También en estos casos, el tratamiento causal hace desaparecer los síntomas. En algunos pacientes se puede confirmar la infección por *Helicobacter pylori* mediante fibroendoscopia gástrica y serología.

Causas locales

La amigdalitis crónica corresponde a la infección amigdalina crónica salpicada por episodios infecciosos agudos puntuales. En ocasiones, los síntomas se limitan a una sola amígdala. Éstos pueden consistir en dolores amigdalinos espontáneos con odinofagia y fetidez del aliento. La exploración de la orofaringe descubre la retención caseosa en las criptas amigdalinas que dejan salir un líquido turbio a la presión del pilar anterior, produciendo inmediatamente aliento fétido. La anamnesis permite descubrir los verdaderos episodios de amigdalitis aguda de repetición. El tratamiento etiológico es en este caso la amigdalectomía bilateral. Siempre se debe investigar la existencia de reflujo asociado y tratarlo.

Causas generales

Las faringitis crónicas pueden ser la expresión faríngea de enfermedades generales. Es el caso de la diabetes, la hiperuricemia, la hipocalcemia y las dislipidemias. La explicación fisiopatológica de la afectación faríngea que se observa en estas enfermedades está relacionada con las modificaciones vasculares generales y nerviosas que provocan.

La hiperuricemia produce una verdadera gota faríngea y se caracteriza porque la mucosa aparece de color rojo oscuro con hipervascularización difusa. El tratamiento de la sobrecarga con uricosúricos o inhibidores enzimáticos debe ser eficaz.

También pueden descubrirse trastornos inmunitarios, congénitos o adquiridos: déficit de la inmunidad no específica (neutropenia y trastornos del quimiotactismo sin neutropenia), déficit humoral (hipogammaglobulinemia) o déficit de la inmunidad celular (infección por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] y déficit secundario a la quimioterapia).

La alergia, especialmente alimentaria, puede ser responsable de hiperreactividad mucosa local: alergias a los alimentos, aditivos, colorantes o conservantes.

El síndrome de Gougerot-Sjögren es una enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza por infiltración linfocítica de las glándulas exocrinas. Tiene como consecuencia una esclerosis bucal y ocular. En la exploración física, la mucosa bucal aparece seca y eritematosa, con atrofia de las papilas de la cara dorsal de la lengua. Falta la saliva o es de aspecto turbio. En la actualidad, los criterios diagnósticos de la enfermedad se encuentran bien definidos y el tratamiento es sintomático, aunque a veces se asocia corticoterapia.

El síndrome de Plummer-Vinson asocia glositis, anillos concéntricos hipofaríngeos o esofágicos, trastornos de faneras, anemia ferropénica y aclorhidria gástrica de origen inmunitario. Produce disfagia intermitente para los sólidos.

Origen iatrogénico

Dentro de las causas medicamentosas destaca la toma de anticolinérgicos, betabloqueantes, psicotropos, antiinflamatorios pirazolónicos y antihipertensivos centrales. El mecanismo que se suele evocar con más frecuencia es la xerostomía que provocan [3, 7].

También es frecuente la faringitis del paciente amigdalectomizado, bien en las primeras revisiones tras la intervención o de forma más tardía. Los trastornos presentes pueden deberse a tres mecanismos:

- la persistencia de restos amigdalinos, por lo general en el polo inferior, a menudo crípticos e infectados que exigen un tratamiento propio;
- el desarrollo de una faringitis en islotes posteriores, que tienden a reemplazar el tejido amigdalino y producen una amigdalitis crónica en la pared faríngea contraria;
- la faringitis cicatrizal a nivel de los pilares y del velo, que se parece a los fenómenos dolorosos, reumáticos de pacientes a menudo neuroartríticos y sensibles a cualquier cambio de temperatura y de humedad, y que presentan brotes inflamatorios o alérgicos locales.

Los pacientes que han recibido radioterapia por lesiones de la esfera ORL suelen presentar hipo o asialia que ocasiona sequedad de la mucosa bucal y faríngea.

■ Diagnóstico diferencial

Con lesión mucosa

Tumores de las vías aerodigestivas superiores

Todo médico debe tener presente la idea de posible neoplasia oculta ante cualquier enfermo con antecedentes de consumo de alcohol y tabaco. Los síntomas dolorosos son localizables, a veces asociados a otalgia, alteración del estado general o disfagia. La exploración física investigará la existencia de tumefacción, ulceración, zona sospechosa en la mucosa rino, oro e hipofaríngea, así como adenopatías cervicales. Ante la menor duda, se practicará endoscopia de las VADS.

Algunas manifestaciones faríngeas no específicas se deben a hemopatías, como la hipertrofia del tejido linfoide que se observa en las leucemias agudas o síndromes linfoproliferativos, y las ulceraciones mucosas de las agranulocitosis.

Infecciones micóticas faríngeas

Su gravedad está subestimada. La micosis pasa del estado saprofito al patógeno debido a la modificación de la mucosa que producen la antibioticoterapia o la corticoterapia [1, 10].

Puede tratarse de candidiasis con el clásico aspecto de muguet, incluso con aspecto seudomembranoso, o de micosis profundas del tipo esporotricosis, ficomicosis y cromomicosis, que son micosis importadas.

Faringitis granulomatosas

Tuberculosis faríngea

Aunque esta localización de la tuberculosis es muy poco habitual, hay que conocerla y tenerla presente, sobre todo en las lesiones de aspecto canceroso. La principal localización es orofaríngea: amigdalina, velar, basilingual y, después, bucal. La localización rinofaríngea es muy poco frecuente y la hipofaríngea resulta excepcional. La toma de muestras reviste una importancia capital.

Sarcoidosis faríngea

La sarcoidosis es una enfermedad sistémica que produce desorden estructural tisular con formación de granulomas epitelioides sin necrosis caseosa. La mucosa faringolaríngea se encuentra afectada en el 5% de los casos.

Sífilis faríngea

Aunque ha disminuido mucho su frecuencia, la sífilis faríngea corresponde a la sífilis secundaria. Aparece presidida por signos cutaneomucosos junto con disfonía y disfagia. Los signos clínicos son faringolaríngeos y van desde el enantema inespecífico a las erosiones en «arañazo» o al aspecto hiperplásico.

Las pruebas serológicas más empleadas son la *venereal disease research laboratory* (VDRL) y el *Treponema pallidum haemagglutination assay* (TPHA). El tratamiento se basa en la penicilina.

Enfermedad de Wegener

La granulomatosis de Wegener afecta al tracto respiratorio y produce clásicamente glomerulonefritis. En general, la faringe no se afecta directamente por esta granulomatosis; son la inflamación de la mucosa nasal y la rinorrea las que pueden irritarla.

Faringitis virales

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

El sida favorece la repetición de infecciones por gérmenes oportunistas, así como la aparición de tumores de Kaposi bucofaríngeos. Se ha demostrado el efecto directo del virus sobre los tejidos linfoepiteliales faríngeos al encontrar partículas virales en el epitelio faríngeo.

Virus Epstein-Barr (VEB)

El VEB es el agente responsable de la mononucleosis infecciosa (MNI). A menudo asintomática, la tríada compuesta por fiebre, adenopatías y faringitis permite sospechar el diagnóstico que se confirmará con la prueba de la MNI.

Citomegalovirus (CMV)

La fiebre parece el único signo asociado a la faringitis por CMV. El diagnóstico es serológico y se debe investigar desde el principio la asociación con la infección por el VIH.

Faringitis herpética crónica

Aunque es muy poco frecuente, debe sospecharse ante la aparición de ulceraciones orofaríngeas, bucales y laríngeas de fondo gris amarillento, con contorno

policíclico rodeado de ribete rojo. El diagnóstico se confirma mediante la biopsia practicada a nivel de las vesículas.

Faringitis bacterianas

«Corynebacterium diphteriae»

Este microorganismo, responsable de la difteria, actúa mediante una endotoxina que se absorbe en la superficie de la mucosa infectada y cuyos efectos pueden afectar al corazón y al sistema nervioso. Signos diferentes a la faringitis guían el diagnóstico: astenia, taquicardia y fiebre. Clásicamente, la alteración mucosa se caracteriza por la presencia de seudomembranas adherentes.

«Chlamydia pneumoniae» y *«Mycoplasma pneumoniae»*

Estudios recientes han demostrado la responsabilidad de algunas bacterias, sobre todo *Chlamydia pneumoniae* [5] y *Mycoplasma pneumoniae,* en las faringitis crónicas. Estos dos gérmenes producen una afectación infecciosa del tracto respiratorio que casi siempre se asocia a la faringitis.

«Fusobacterium necrophorum»

Fusobacterium necrophorum, bacilo anaerobio, podría producir faringitis. Para algunos autores, el origen de esta lesión se situaría en los tejidos submucosos faríngeos.

Otras faringitis específicas

Faringoqueratosis

La faringoqueratosis es un dato exploratorio muy poco frecuente que se caracteriza por la presencia en la amígdala, y en la base de la lengua, de «clavos queratósicos» blanco amarillentos, muy adherentes a la mucosa. Su exéresis no impide la aparición de otras formaciones en la proximidad.

Enfermedad de Crohn

La enfermedad de Crohn es responsable de una alteración inflamatoria cuyo mecanismo fisiopatológico sigue siendo todavía mal conocido. Puede verse afectado todo el tracto digestivo, desde la cavidad bucal hasta la mucosa anal. La faringitis se observa en el 9% de los pacientes afectados por la enfermedad de Crohn.

Sin lesión mucosa clínica

Etiología osteoarticular

En la cervicoartrosis, el proceso de periartrosis es esencial. Los fenómenos inflamatorios producen la contractura dolorosa de los músculos constrictores de la faringe y, en ocasiones, espasmos esofágicos. Es frecuente que en la madurez la radiografía muestre signos discretos de artrosis cervical, confirmándose la hipótesis si la exploración revela la existencia de síntomas dolorosos a la presión o a la movilización, al mismo tiempo que aparece o se exacerba el trastorno faríngeo. El tratamiento se basa en estos casos en los antiinflamatorios, a los que se debe asociar, si es preciso, protectores gástricos.

La apófisis estiloides larga puede producir dolor faríngeo unilateral, que se confirma al provocar dolor con la palpación de la faringe.

Por último, las molestias faríngeas también pueden producirse por trastornos de la articulación dental o por conflictos meniscoarticulares a nivel de la articulación temporomandibular.

Etiología orofaríngea

Los pacientes que tienen la úvula larga pueden presentar molestias en la deglución. Es posible que el estrechamiento de la luz orofaríngea dificulte la respiración, produciendo molestias faríngeas matinales debidas a la desecación mucosa nocturna.

Parestesias faríngeas

El aspecto funcional de la faringitis crónica y su origen psicosomático deben plantearse después de haber descartado el resto de diagnósticos. Parece que el principal síntoma de esta fijación psicosomática es la falsa disfagia, en la que el paciente, capaz de ingerir normalmente los alimentos, experimenta una molestia durante la deglución en vacío de la saliva. El enfermo multiplica estas degluciones para verificar la persistencia de su dolor y comprobar, por tanto, que existe una razón física auténtica de su padecimiento. El síntoma se fija de forma electiva sobre una zona o un órgano ya sensibilizado, parte privilegiada de su anatomía que imagina el enfermo, que sólo el médico es capaz de visualizar. Aunque resulta difícil, en estos pacientes la conversación franca puede conducir poco a poco a que el enfermo tome conciencia de la significación del síntoma y de su elaboración. El tratamiento se basa en la psicoterapia.

■ Tratamiento

El tratamiento de las faringitis crónicas debe plantearse desde el punto de vista etiológico y preventivo, antes que sintomático, sobre las molestias faríngeas [2, 11].

Normas higienicodietéticas

Es obligatorio suprimir los factores irritativos externos, como el consumo de tabaco (tanto activo como pasivo) y de alcohol, proponiendo al paciente técnicas y ayudas para la deshabituación (ayudas psicológicas y medicamentosas). Puede restringirse el consumo de sal y picantes, y proponer una dieta hipouricémica, con el suficiente aporte hídrico.

En caso de faringitis crónica profesional, es necesario el uso de protectores específicos y la adaptación de un puesto asegurado con la colaboración del médico del trabajo [3, 7].

Tratamiento local

En ocasiones, es necesario indicar algunas intervenciones quirúrgicas para suprimir los focos infecciosos u obstructivos orofaríngeos o nasosinusales, o para restablecer la adecuada permeabilidad nasal. Estas indicaciones deben valorarse cuidadosamente y hay que ser comedidos en las expectativas de los resultados, aunque a veces los pacientes sean muy insistentes [7].

Se iniciará el tratamiento específico de las enfermedades nasosinusales: tratamiento médico, e incluso quirúrgico, de las sinusitis crónicas, así como corrección quirúrgica de la obstrucción nasal debida a desviación septal, hipertrofia de cornetes o concha bullosa.

El objetivo consiste en restablecer la correcta ventilación de las fosas nasales y hacer que desaparezca la rinorrea posterior.

Los focos infecciosos dentales se tratarán sistemáticamente, y se reevaluarán y adaptarán las prótesis dentales.

Los focos infecciosos amigdalinos crónicos, diagnosticados por la exploración y la anamnesis, se erradican mediante amigdalectomía bilateral; a veces puede ser suficiente una intervención con láser.

Si las muestras locales obtenidas demuestran la existencia de micosis, ésta se debe tratar, además de vigilar la eficacia del tratamiento.

Los lavados nasales con suero hipertónico y los gargarismos con bicarbonato sódico pueden aliviar el dolor y desprender las lesiones costrosas de la faringe.

Tratamiento regional

En caso de reflujo gastroesofágico comprobado o simplemente sospechado, se debe instaurar el tratamiento de prueba.

Si se sospecha la existencia de cervicoartrosis, se puede solicitar revisión por parte del reumatólogo.

Tratamiento general

La compensación de los trastornos del metabolismo (de los lípidos, glúcidos o proteínas) puede mejorar los signos faríngeos.

Los antiinflamatorios tienen casi siempre efecto inmediato y sedativo sobre las manifestaciones inflamatorias, pero no pueden utilizarse de forma prolongada como tratamiento de fondo debido a sus contraindicaciones propias, sobre todo digestivas.

En caso de alergia, puede resultar muy beneficioso para el paciente evitar la exposición al alergeno responsable del tratamiento antihistamínico.

Crenoterapia

Representa una terapia muy antigua con eficacia reconocida en el tratamiento de enfermedades infecciosas y alérgicas de la esfera ORL: las aguas sulfuradas y sulfatadas se emplean para los problemas infecciosos, y las aguas bicarbonatadas cálcicas arsenicales para las afecciones alérgicas. Se utilizan diversas técnicas, que van desde los lavados nasales hasta los gargarismos y los aerosoles.

Las faringitis crónicas derivadas de trastornos metabólicos podrían tratarse en balnearios especializados en enfermedades digestivas o urinarias.

■ Bibliografía

[1] Bassiouny A, El Refai A, Nabi E, Fateen A, Hendawy D. Candida infection in the tongue and pharynx. *J Laryngol Otol* 1984;**98**:609-11.

[2] Bonfils P. *Conduite à tenir devant une pharyngite chronique. Pathologie ORL et cervico-faciale*. Paris: éditions Ellipses; 1997 354-358.

[3] Bouche J. Les pharyngites chroniques, essai pathogénique et thérapeutique. *Rev Laryngol* 1978;**99**:29-37.

[4] Dubreuil C, Haguenauer JP, Morgon A. *Physiologie du pharynx. ORL pour le praticien*. Paris: SIMEP; 1987.

[5] Falck G, Engstrand I, Gad A, Gnarpe J, Gnarpe H, Laurila A. Demonstration of *Chlamydia pneumoniae* in patients with chronic pharyngitis. *Scand J Infect Dis* 1997;**29**:585-9.

[6] Faure G, Béné MC. Système de défense des voies aérodigestives supérieures. In: Wayoff M, Paliwoda A, editors. *Immunité et inflammation en ORL*. Paris: Collection Jouveinal; 1991. p. 519-28.

[7] Gaillard J, Haguenauer JP. Pharyngites et amygdalites chroniques. *J Fr ORL* 1978;**27**:423-32.

[8] Margarino, Scala, Rossi, Mereu, Dessy, Sogno, Bonelli, Badellino. Immunologic study of patients with chronic pharyngitis. *Acta Otorhinolaryngol Ital* 1989;**9**:399-402.

[9] Reinert P. Pathologie du système immunitaire de la muqueuse nasopharyngée. In: Wayoff M, Paliwoda A, editors. *Immunité et inflammation en ORL*. Paris: Collection Jouveinal; 1991. p. 83-7.

[10] Starosvetskii BV. Chronic pharyngitis of mycotic etiology. *Vestn Otorinolaringol* 1988(5):27-31.

[11] Stephenson K. Acute and chronic pharyngitis across the lifespan. *Lippincotts Care Pract* 2000;**4**:471-89.

L. Vazel (laurent.vazel@free.fr).
C. Martins.
G. Potard.
R. Marianowski.
Service d'otorhinolaryngologie, Centre hospitalier universitaire Morvan, 5, avenue Foch, 29609 Brest cedex, France.

Ogni riferimento a questo articolo deve portare la menzione: Vazel L., Martins C., Potard G., Marianowski R. Faringitis crónicas. EMC (Elsevier SAS, Paris), Otorrinolaringología, 20-530-A-10, 2005.

Disponible en www.emc-consulte.com (sitio en francés)
Título del artículo: **Pharyngites chroniques**

Algoritmos · Illustraciones complemtarias · Vídeos / Animaciones · Aspectos legales · Información al paciente · Informaciones complementarias · Autoevaluación